

一项观察性、双向队列研究评估达妥昔单抗 β 和常规治疗用于高危神经母细胞瘤患者维持治疗的长期有效性和安全性

知情同意书

(8-18 岁版)

版本号: 1.0

版本日期: 2021 年 11 月 23 日

研究编号: BGB--dinutuximab_beta-102

研究单位: 首都医科大学附属北京儿童医院
北京市西城区南礼士路 56 号



2021. 11. 23

一项观察性、双向队列研究评估达妥昔单抗 β 和常规治疗用于高危神经母细胞瘤患者维持治疗的长期有效性和安全性

知情同意书

(8-18 岁版)

版本号: 1.0

版本日期: 2021 年 11 月 23 日

研究编号: BGB--dinutuximab_beta-102

研究单位: 首都医科大学附属北京儿童医院
北京市西城区南礼士路 56 号



知情同意书

您好！

我们将邀请您参加一项观察性、双向队列研究评估达妥昔单抗β与和常规治疗用于高危神经母细胞瘤患者维持治疗的长期有效性和安全性的临床研究。

家长会帮助您来阅读和理解这份资料，医生会向您解释这个研究的更多细节，这份资料是为了帮助您记住相关内容，如果您有看不懂的字或词语，您可以问医生或家长。

本研究由首都医科大学附属北京儿童医院负责，方案已经得到首都医科大学附属北京儿童医院伦理委员会审核同意。本研究可能在临床研究相关登记平台上备案和披露，但任何平台都不会包含可以识别出您身份的信息。

本知情同意书对研究目的、步骤、可能的风险与受益、参与研究可能带来的不适和注意事项等进行了解释，用来帮助您决定是否参加这项研究。请您仔细阅读并确保理解这份知情同意书，确保您的疑问得到了满意的解答，但请注意我们无法对研究结果做出承诺。如果您有任何疑问，请随时向医生咨询。

如果您参加研究，您将获得一份您与医生双方签字后的知情同意书。

1. 为什么开展这个研究？

开展本研究的目的是在真实医疗环境中评估高危神经母细胞瘤患者一线维持治疗阶段使用达妥昔单抗β与常规治疗方案的有效性和安全性。

达妥昔单抗β于2021年8月在我国获批，适用于治疗超过12月龄的高危神经母细胞瘤患者，这些患者既往接受过诱导化疗且至少获得部分缓解，并且随后进行过清髓性治疗和干细胞移植治疗，以及有复发或难治性神经细胞瘤病史、伴或不伴残留疾病的患者。该药物可以作用于神经母细胞瘤细胞上过度表达的GD2，与其抗原特异性结合，通过诱导细胞毒性而发挥靶向抗肿瘤作用。

2. 参加这个研究，都有哪些步骤？

本研究是一项多中心、观察性、双向队列研究。我们将基于您的诊断和治疗信息进行数据采集，不会进行任何临床干预。在结束临床治疗之后，需要您配合

按照临床医生建议的访视时间点进行随访,以进一步观察治疗效果及可能出现的副作用。

2.1 筛选:

我们将根据如下内容对您的有关情况进行评估,需要全部符合以下条件,才有可能参与本研究:

- 已签署知情同意书并具有遵守研究要求的能力;
- 年龄 ≥ 12 个月, <18 岁;
- 经组织病理学确诊,或经影像、骨髓、尿儿茶酚胺代谢产物等检查确诊的神经母细胞瘤;
- 诊断为高危神经母细胞瘤(根据2009年国际神经母细胞瘤危险度分组系统或2015年版中国儿童神经母细胞瘤诊疗专家共识或2007年COG危险度分期标准);
- 先前接受过诱导化疗并至少获得部分缓解,并且随后进行过清髓性治疗和干细胞移植治疗;
- 接受维持治疗之前至少达到部分缓解。

另外,如果您在进入维持治疗前曾接受过达妥昔单抗 β (达妥昔单抗 β 的药代动力学研究除外)或其他抗双唾液酸神经节苷脂2治疗,或者目前正在参加另一项干预性临床研究(比如对患者长期生存随访进行了干预的研究),也不能参加本研究。

本研究主要对您的日常诊疗信息进行收集和记录,主要信息收集范围包括:

- 一般人口学信息:包括出生日期、年龄、性别、民族;以及身高、体重、体表面积等;
- 进入维持治疗前7天内的体温、脉搏、呼吸和血压
- 进入维持治疗前7天内的一般检查、皮肤黏膜、淋巴结、头颈部、胸部(心脏和肺脏)、腹部、肌肉骨骼、神经系统、精神状况等的评价
- 既往疾病史:既往临床重大疾病史、手术史或其他肿瘤史
- 参加既往临床试验的信息(如有):曾经参加的临床试验或正在参加的其他临床试验
- 神经母细胞瘤疾病史:包括但不限于临床诊断、诊断日期、临床分期、危险

度评估、所依据的分级标准、病理组织学分类、肿瘤细胞分化程度、肿瘤部位、受累部位、器官等

- 神经母细胞瘤的治疗史：手术史（手术日期、手术名称、手术位置、手术医院），诱导治疗以及巩固治疗史（包括治疗起止时间、治疗方案、治疗药物、剂量、清髓治疗、造血干细胞移植的情况、放疗史等）以及进入维持治疗前的反应评估
- 进入维持治疗前 14 天内的血常规、尿常规、血氧饱和度、肝功能、肾功能、生物学标记物、听力检查、心电图、心脏彩超等
- 进入维持治疗前 28 天内的肿瘤影像学检查
- 骨髓检查：骨髓细胞形态学、微小残存病灶等
- 遗传学检查
- 曾用药物：前 28 天内的曾用药物
- 严重不良事件

如果您需要了解更详细的入选标准或对入选标准有任何疑问，请随时询问研究医生。

有可能结合您已有的诊疗情况进行评估之后，医生发现您并不适合参与本研究，将不会进一步收集和记录您后续治疗的相关信息。另外，研究医生将判断您是否有再次筛选的可能性（比如完成了一些其他的治疗或检查）。如果您进入再次筛选，您需要重新签署知情同意书。

2.2 维持治疗及维持治疗期间的访视

如果您已经结束了维持治疗的用药，我们会采集您过去在维持治疗期间的治疗和检查信息。医生还会根据临床诊疗规范和实际情况，为您安排后续的访视，还请您配合，这些访视过程中的医疗和检查信息，我们也会做收集。

如果您准备进入维持治疗，期间需要您积极配合各项检查及治疗，医生会对您进行临床检查，包括肿瘤的影像学检测评估，以评价您接受治疗后的安全性和疗效。因此在来院访视时，请主动告诉医生您所有的身体不适，包括出现与持续的时间、症状以及是否在外院就诊或吃过什么药物等，医生也将通过各项检查与问诊了解您的身体情况。每次访视后，医生都会给出相应的医嘱，请务必遵循医

生的指导。

维持治疗阶段如果您接受达妥昔单抗β治疗，可根据说明书的建议，达妥昔单抗β为每35天为一个疗程，共5个疗程；如果您接受常规治疗，比如使用13-顺式维甲酸治疗，可根据您的医生建议的治疗方案接受治疗。各种治疗方案的相关信息会被如实记录。

药物	剂量	给药频率	给药途径
达妥昔单抗β	日剂量为 10 mg/m ²	每个周期前 10 天连续输注给药	静脉给药
	日剂量为 20 mg/m ²	每个周期前 5 天连续输注给药	静脉给药

在维持治疗期间，您需要配合医生做访视，一般是第1个疗程的访视在维持治疗首次用药当天完成，后续疗程的访视会在每个疗程用药第一天或者用药第一天的前后7天内完成。在此期间，我们基于您的临床诊疗信息来收集，包括：

- 生命体征、体格检查、身高、体重、体表面积
- 实验室检查：包括血常规、尿常规、血氧饱和度、肝肾功能、电解质、凝血功能
- 生物标记物
- 听力检查、眼底及视力检查、心电图、心脏彩超
- 肺部 CT
- 3 个疗程后进行 1 次肿瘤影像学检查：原发灶、转移灶的 B 超，增强 CT 或 MRI 检查，头颅 MRI，胸部 CT
- 骨髓检查（如有）
- 用药情况：每个疗程用药剂量和治疗日期等
- 合并用药/伴随治疗
- 疼痛评估
- 治疗期间的不良事件、严重不良事件
- 治疗期间的合并用药或其他治疗
- 医生做出的治疗反应评估记录
- 失访或死亡（如有）：记录日期、原因。

2.3 随访访视

医生将结合临床实践给您制定随访计划。我们建议您能按照随访计划返回医院进行访视。如果出于特殊原因不能返回，研究人员每 3 个月至少一次通过远程方式询问您的情况。研究人员将收集您的如下信息：

- 体格检查
- 生物标记物
- 肿瘤影像学检查： 原发灶、转移灶的 B 超，增强 CT 或 MRI 检查，骨扫描（如有），MIBG/PET-CT（如有）
- 骨髓检查：骨髓常规，微小残存病灶等
- 不良事件和严重不良事件
- 医生做出的反应评估记录
- 失访或死亡（如有）：记录日期、原因。

研究期间，您可能会出现超出医生建议的随访计划外的其他访视，医生会根据您的实际情况及临床指征与您充分沟通，评估访视内容会在病历中做好记录。

如果研究过程中出现了非预期的重大或不可接受的风险，或者由于监管机构、伦理委员会的意见，或者研究药物的疗效或安全性问题，本研究可能提前终止，届时我们将不会再继续收集您的信息。研究也可能会暂停，如果引起研究暂停的药物安全、方案依从性、数据质量问题得到解决，并得到申办方、伦理委员会或药品监管部门的同意，则研究可继续进行，我们会继续收集您信息。

另外，您可在任何时间因任何原因退出研究并撤销知情同意。如果您退出并撤销了知情同意，我们将不再收集您的信息。

3. 参与研究可能的不良反应、风险和不适

任何临床研究都有一定的风险，您可能接受的是对您无效或疗效有限的治疗，您的情况可能恶化或者没有改进。任何研究药物都有可能会出现其他不可预见的甚至是严重的副作用。如果您在治疗期间有任何不适，一定要及时通知您的研究医生，他/她将对此做出判断和医疗处理。

在参加整个研究期间可能会出现的副作用及风险包括但不限于下列各项：

3.1 达妥昔单抗 β 可能引起的不良反应：

已在 514 例高危复发性/难治性神经母细胞瘤患者中评价了达妥昔单抗 β 的安全性。最常见的不良反应是发热和疼痛（通常发生于达妥昔单抗 β 首次输注期间，并在治疗过程中减轻。最常见的是腹痛、四肢疼痛、背痛、胸痛或关节痛），其他常见的不良反应为呕吐、腹泻、毛细血管渗漏综合征、超敏反应（比如低血压、荨麻疹、支气管痉挛、细胞因子释放综合征等）、眼科问题（视力调节受损、瞳孔散大、视物模糊或畏光，这些症状在治疗终止后通常是可逆的，还发生眼肌麻痹和视神经萎缩）和周围神经病变等。

3.2 不可预知风险

研究药物在临床研究中均可能出现未能预期的或不可预知的风险发生，包括不可预知的风险种类和严重程度，可能会对您造成伤害，甚至危及生命。

3.3 其他风险

在医疗诊疗中相关的医学检查也可能会给您带来风险，如抽血、血压测量、心电图检查等可能引起局部皮肤的淤青，影像学检查的辐射伤害或者造影剂的过敏等。

4. 参加研究可能的受益

目前高危神经母细胞瘤的一线维持治疗选择药物有限，基于已公布的达妥昔单抗 β 用于高危神经母细胞瘤一线维持治疗的临床数据，显示达妥昔单抗 β 可带来更好的临床疗效，并且有可控的安全性特征，获益/风险评估被视为有利。

本研究基于医院日常诊疗的信息来收集数据。不论您是否参加本研究，这些日常诊疗都是您治疗疾病所需要的环节。本研究不提供药物，也不提供相应的检查费用。如果您同意参加本项研究，我们不能保证您直接从研究中受益，但您的参与将为其他患病的小朋友做出贡献，在此我们向您表示感谢！

5. 您的责任

- 建议您按医生和您约定的随访时间来医院就诊。您的及时接受随访非常重要，医生将判断治疗是否真正起作用。
- 在研究期间中，医生将询问您的治疗情况，请您描述您的反应和感觉，

与您讨论可能的副作用。

- 如您有其它合并疾病须继续服用相应的药物，请及时告知您的研究医生。如果您正在使用任何“非处方药”、草药和天然疗法，请您一定告知您的医生。
- 参与本研究过程中，如果您出现第二原发恶性肿瘤需进行局部抗肿瘤治疗（同步放疗或癌症相关的手术等）时，请及时和医生联系，医生将会对目前的研究治疗进行评估，并与您沟通后续的治疗计划。如果您不确定能否使用某种药物或接受某种治疗，请您及时向您的研究医生寻求指导。
- 如果您准备参加另一项临床研究，您要让负责那项研究的医生知道您正在参加本研究。您应该请那位医生与您的研究医生联系，讨论其它的必要治疗措施。
- 您需要把在本研究进行期间准备接受的所有医学治疗告诉您的研究医生（例如择期手术或者放疗）。如果您不确定能否接受某种治疗，请您及时向您的研究医生寻求指导。
- 如果您在研究过程中因为任何不适在不是您的研究医生处就诊请告知医生您正在参加一项临床研究，请对方与您的研究医生联系，讨论必要的治疗措施。
- 除了您本人之外，希望您家属成员中至少有一位能够了解您将参与的临床研究并能关心您的病情，同时在后续随访中能够向医生反馈您的健康状况。您的家属应在您发生严重不适时（包括需住院进行治疗）时及时通知您的研究医生。
- 如果您的地址、电话号码或者其他联系信息发生了变化，请告诉您的研究医生。

6. 我们怎么保护您的信息

我们会按照法律的要求为您的研究记录保密。所有您的医疗信息仅用于本次研究，您的个人信息也是保密的，可以识别您身份的信息不会透露给研究小组以外的任何人员。

一项观察性、双向队列研究评估达妥昔单抗 β 和常规治疗用于高危神经母细胞瘤患者维持治疗的长期有效性和安全性

知情同意书签字页

医生已经将这份资料向我做了详细的说明，不明白的字和词语我也问过了医生。我理解参加本项研究是自愿的。经过考虑后，我愿意参加这项研究，并且配合医生的诊疗、随访，如果有不舒服的情况，我会及时告诉父母或者医生。

我明白我任何时候都可以停止这项研究，不会影响医生帮助我进行任何治疗。

患者姓名（正楷）：_____ 签名：_____ 日期：_____年__月__日__时__分

监护人姓名（正楷）：_____ 签名：_____ 日期：_____年__月__日__时__分
(此处签字与监护人版知情同意书保持一致，单独签署即可)

研究者：我确认已就本研究的性质、目的、要求和可能风险向患者及其监护人进行了详细的解释和告知，并回答了所有相关问题。此知情同意书一式两份，研究者与患者/监护人各留一份已签字的知情同意书。根据国家法律法规和本研究的方案，我将准确的执行临床研究，并采取必要的措施以保障上述患者的权利和安全。

姓名（正楷）：_____ 签名：_____ 日期：_____年__月__日__时__分